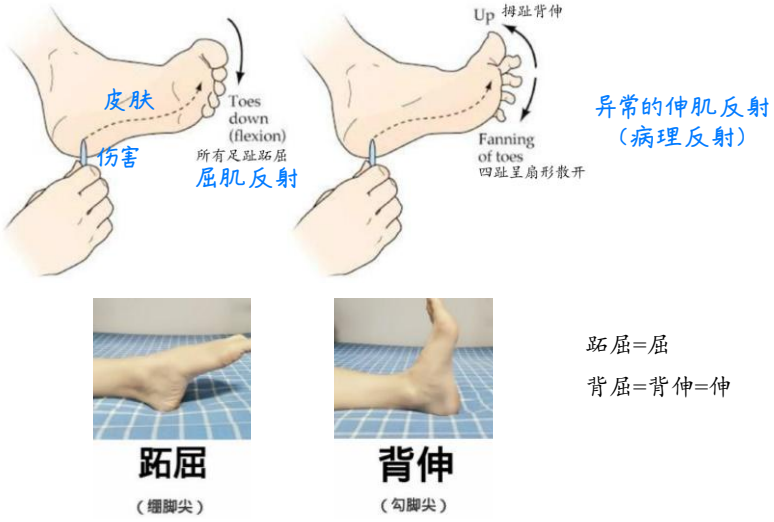
3.Babinski 巴宾斯基征（今晚 ttsx 划划室友 jio 底板）



爬行时期：足底受刺激引起拇趾背伸+四趾呈扇形散开（方便爬高）——原始反射

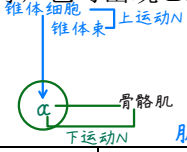
直立行走时期：足底受刺激引起所有足趾跖屈（方便迈步），它抑制了原始反射

（大脑皮层通过皮层脊髓侧束实现）
抑制了原始反射

Babinski 征(-)是正常的屈肌反射（所有足趾跖屈）

①当**皮层脊髓侧束受损**→原始反射被释放——拇趾背伸+四趾呈扇形散开——Babinski 征(+)，**Babinski 征(+)是异常的伸肌反射（病理反射）**异常、病理-不是正常的
原始反射的释放

②婴儿因皮层脊髓束发育不完全、成人在深睡或麻醉时，也可出现 Babinski 征(+)



4.上 VS 下运动神经元病变

共同表现:丧失随意运动(瘫)	肌张力(牵张反射)↑ 硬瘫/痉挛性麻痹	肌张力(牵张反射)↓ 软瘫/弛缓性麻痹
病变	上运动神经元	下运动神经元
栗子	内囊出血锥体束下行经过内囊	脊髓灰质炎破坏α运动神经元
Babinski 等病理征	+ 皮层脊髓束受损	-
肌力	减弱 ——都瘫了——	减弱
牵张反射（腱反射和肌紧张/肌张力）深反射	增强（高位中枢抑制减弱→深反射增强）膝跳反射还是能伸小腿、这不叫随意运动、这叫反射运动 ttsx	减弱（反射弧受损）牵张反射中枢在脊髓
浅反射	减弱（高位中枢易化减弱→浅反射减弱）大脑喜欢肤浅、不喜欢深奥 大脑皮层抑制深反射,易化浅反射	减弱（反射弧受损）
肌萎缩	不明显 营养因子	明显（失去神经营养作用）
麻痹范围	广泛	局限

高位中枢抑制牵张反射,上运动神经元(高位中枢)病变后抑制作用减弱,牵张反射增强,腱反射、肌紧张也增强
下运动神经元病变就是整个反射弧都有问题,不能进行反射,骨骼肌不能收缩,牵张反射减弱